

9h

MARIA INES FARIAS DE PAIVA	
HD:	AOS + Depressão
MEDICO:	Dr. Alberto
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	
PA:	
OXIMETRIA:	

26/09 P = 7.0 ↑ a pressão pl 8.0 IAH: 84.3

21 IAH = 7.8

m. de uso: fh 24

Regula a pressão. — Jua

02/08 P = 8.0 ↑ P inicial = 5.0

21 IAH = 5.4 < 5.1

m. de uso: 8hrs

Jua

17/08 P = 8.0 cmH₂O

21 IAH = 4.8

m. de uso: fh 42'

↑ pl 8.5 cmH₂O

Jua

08/09 P = 8.6 cmH₂O

21 IAH: 3.5

m. de uso: fh 20'

reclamação

Jua

15/10 P = 8.6 cmH₂O

21 IAH: 3.1

m. de uso: 7hrs

Jua

17/11 P = 9.0

21 IAH: 3.2

m. de uso: 6h36

Jua

- comprou o CPAP Elite S9 e humidificador

R\$ 2000,00 - pag Tado 03/01/2022

16/12 P = 9.0

IAH = 3.9

m. de uso: 6h50

Jua

07/12 esta fazendo exerc físico
Bem adaptada, segue assim
IAH = 1.6 / m. uso: fh

20/02 Bem adaptado (IAH = 3,5 / m. de uso)
fh 30'

26/04 P = 9,0 cmH₂O
IAH = 2,4 / hr
m. de uso: fh 23'
Bem adaptado

06/07 P = 9,0
IAH = 2,2 / hr
m. de uso: fh 24'
Fuga: 9,6 el/min.
Boca seca.

04/10 P = 9,0 cmH₂O
IAH = 2,4 / hr
m. de uso: fh

16/02 P = 9,0 cmH₂O
IAH = 2,5 e / hr
m. de uso: fh
Fuga = 10,8 el/min

10/05 P = 9,0 cmH₂O
IAH = 3,2 e / hr
m. de uso: fh
Fuga = 22,8 el/min

12/07 P = 9,0 cmH₂O
IAH = 3,0 e / hr
m de uso = 7 horas
fuga = 15 el/min.

29/08 P = 9,0 cmH₂O
IAH = 1,9 e / hr
m. de uso: fh 30'

13/09/23 P = 9,0 cmH₂O
IAH = 2,2 e / hr
m de uso = fh 30'
fuga = 3 el/min

13/11/23 P = 9,0 cmH₂O
IAH = 2,3 e / hr
m de uso = 7 horas
fuga = 24 el/min

Fez nova PSG dia 09/10/23 / CPAP = 5,2 cmH₂O
IAH = 5 e / hr
Ajuste P: 6,0 cmH₂O fixa.
Amihil - porque ha pueru p/ o sono.

Bem adaptado

fua

Bem adaptado

fua

fua

- Bem adaptada

-

relata que está + sonolenta.

↑ P = 9,6 e inicial 6.

fua

Princial 6 cmH₂O.

Bem adaptada.

17/01 P= 6cm H₂O → musculação 5x sem há 1 mês
2024 IAH= 1,3 e/h
m de uso= 6h 50' → mantém Arnitil p/ sono.
fuoga= 5 l/min Silvia

20/03/24 P= 6,0 cm H₂O
IAH= 1,8 e/h mantém ativ. física
m de uso= 7h 09'
fuoga: pac 95°: 4,8 Natacha

24/05/24 P= 6,0 cm H₂O
IAH= 1,2 e/h
m de uso= 6h 39m Bem adaptada
fuoga P95: 18 l/min Natacha

26/05/24 P= 6 cm H₂O
IAH= 1,7 e/h Bem adaptada
m de uso= 7h 10m Natacha
fuoga: 1,7 l/m

25/10/24 P= 6 cm H₂O * nota apresentou mensagem vida
IAH= 1,7 e/h útil engatada *
m de uso= 7h 10 Silvia
fuoga= mas ainda está funcionando

31/01/25 P= 6,0 cm H₂O Bem Adaptada
IAH= 2,1 e/h
m de uso= 6h 47min
fuoga= 12 l/min Silvia

25/04/25 P= 6,0 cm H₂O Bem Adaptada
IAH= 2,3 e/h
m de uso= 6h 52min Sem queixas
fuoga= 0 l/min Silvia

29/07/25 P= 6,0 cm H₂O Bem Adaptada
IAH= 1,8 e/h
m de uso= 6h 55min prong entregou - disse que
fuoga= 12 l/min tem nova em casa. Silvia



clínica

DR. ALBERTO REMESAR
TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO SONO
PSIQUIATRIA

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ
Certificação em Medicina do Sono
Instituto Brasileiro de Sono
Mestre em Psicologia pela UFPA
Doutor em Ciências pela UFPA
CRM-SP: 69.730

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES
Medicina do Sono
Crianças e Adolescentes
CRM-SP: 62.858

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Maria Inês Farias de Paiva

EXAME nº: 4870

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 07/05/2021

IDADE: 53 anos

Comentários:

Exame iniciado às 21h41min e concluído às 06h00min. A latência para o sono foi de 101 minutos e a latência para o estágio REM, de 281 minutos. O tempo total de sono foi de 185 minutos (03h05min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 37%. A distribuição do sono registrado mostrou 32,2% de estágio 1, 42,7% de estágio 2, 15,1% de estágio 3 e 10% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 273,5 minutos em vigília, ocorreram 189 microdespertares (índice: 61,3/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 84,3/hora, sendo 30,8 apneia/hora e 53,5 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 84,3/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 91%, sendo a média de 92% e a mínima de 80%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono

TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (84,3/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (84,3/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente no decúbito dorsal e durante o estágio REM, arritmia cardíaca e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 60; máxima: 77 bpm.

O ronco foi esporádico e baixo.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente demorou a dormir (latência para o sono: 101 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (281 min; normal: 70 a 120 min). O sono foi fragmentado pelos despertares longos (eficiência do sono: 37%; normal: 85% ou acima) e microdespertares (índice: 61,3/hora; normal até 15/hora). Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (32,2%; normal: 8-10%) e 3 (15,1%; normal: 10-12%), e a redução dos estágios 2 (42,7%; normal: 45-55%) e REM (10%; normal: 20%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 3 (normal até 9; máxima: 24).

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM-69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730

clínica
DR. ALBERTO REMESAR

DR. ALBERTO JORGE REMESAR LOPEZ

DR. ELITÂNIA MARINHO PONTES

CRM-SP 82.858

CRM-SP 69.730

LAUDO DA PSIQUIATRIA POLISSONOGRAMA

NOME: Maria Inês Farias de Paiva

EXAME nº: 4870-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez

DATA: 09/10/2023

IDADE: 56 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h12min e concluído às 05h56min. A latência para o sono foi de 27 minutos e a latência para o estágio REM, de 126 minutos. O tempo total de sono foi de 399 minutos (06h39min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 85,8%. A distribuição do sono registrado mostrou 4,4% de estágio 1, 46,2% de estágio 2, 26,9% de estágio 3 e 22,4% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 39 minutos em vigília, ocorreram 63 microdespertares (índice: 9,5/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 5/hora, sendo 0,6 apneia/hora e 4,4 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 5/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 96%, sendo a média de 92% e a mínima de 81%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

A paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia Matos e Faria (CREFITO: 29544 F). Ela usou a máscara nasal Mirage Activa medium (Resmed®) durante o exame. A pressão final recomendada do CPAP foi de 5,2 cm de H₂O.

Registraram-se aumentos leves dos índices de apneia/hipopneia (5/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e de distúrbio respiratório (5/hora), e alguns episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina. O ritmo cardíaco foi sinusal e as frequências cardíacas foram: mínima: 62; máxima: 79 bpm.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes e de ronco com a pressão adequada.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 27 min; normal até 30 min) – ela ingeriu um comprimido de zolpidem 10 mg às 21h30min. A latência para o estágio REM estava alongada (126 min; normal: 70 a 120 min). A eficiência do sono (85,8%; normal: 85% ou acima) e o índice de microdespertares (9,5/hora; normal até 15/hora) mantiveram-se nos limites da normalidade. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 3 (26,9%; normal: 10-12%) e REM (22,4%; normal: 20%), e a redução do estágio 1 (4,4%; normal: 8-10%). A porcentagem do estágio 2 (46,2%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

Sem movimentos periódicos de membros.

Dr. Alberto Jorge
Remesar Lopez
Médico
CRM-SP 69.730

Dr. Alberto Jorge Remesar Lopez
Diretor Técnico Médico
CRM-SP 69.730